

שינויים במצב ההכרה



סקירת מערכות כללית

A - נתיב אוויר

- הפרשות בחלל הפה / גוף זר

B - מצב נשימה

- ציאנוזיס, קפנומטריה, האזנה, דפוס נשימה

C - סירקולציה

- לחץ דם, דופק פריפרי, צבע עור, טמפרטורה, מילוי קפילרי

D - מצב נוירולוגי

- אישונים, סימני נשיכת לשון, אובדן שליטה על הסוגרים, סוכר, חסכים נוירולוגיים

E סריקה גופנית

- דימומים / חבלות / משאבת אינסולין, מדבקות פנטניל, אנגיואדמה, אורטיקריה

אנמנזה סביבתית

שינויים במצב ההכרה

- מונח כללי המתאר אדם שאינו בהכרה מלאה (רמת הכרה $A < 14$ או $GCS < 14$)

גורמים עיקריים:

- ירידה באספקת הדם למח
- ירידה באספקת האנרגיה למוח
- ירידה בתפקוד המוחי
- לכלל הגורמים שהוזכרו ישנן סיבות רבות ומגוונות
- האבחנה המבדלת בין כלל המצבים מצריכה ידע, חשיבה, בדקיה גופנית מדוקדקת לצד פעולה מהירה ועין קלינית מיומנת



טיפולים ובדיקות עיקריים

A •

- יש לתמוך בנתיב האוויר של המטופל
- ייתכן צורך בניהול נתיב אוויר מתקדם
- אם ניתן - השכיבו את המטופל על צידו

B •

- היפוקסיה והיפוקסמיה הינם גורמים נפוצים לשינויים הכרתיים
- ספקו חמצן לכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה - לפי הצורך או אם הסטורציה מתחת ל-92%

C •

- בנוכחות שוק יש להרים רגליים ולפעול לפי עקרונות הפרוטוקול "ירידה בפרפוזיה שלא כתוצאה מטרומה" לאחר אנמנזה
- יש לשקול לבצע אק"ג לכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה (בהתאם לאנמנזה ודחיפות המקרה)

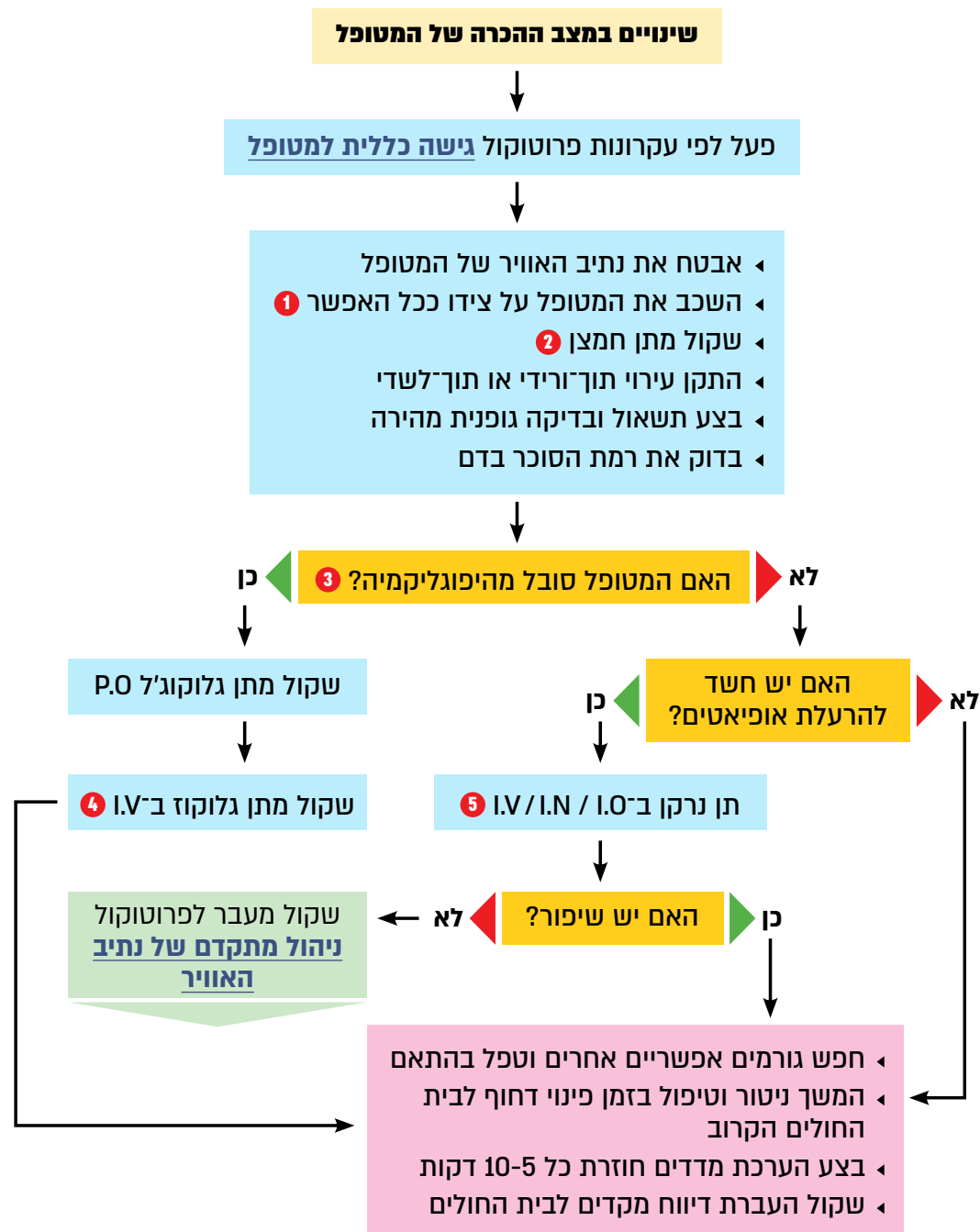
טיפולים ובדיקות עיקריים

D •

- יש לבדוק סוכר ואישונים לכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה
- בעת זיהוי היפוגליקמיה - טפלו באמצעות סוכר PO או IV בהתאם לפרוטוקול

E •

- חשפו סימני חבלת ראש, סימני זיהום ומחוללי זיהום (ספסיס), נתקו משאבת אינסולין והורידו מדבקות תרופות אשר ניכר כי קשורות למצב המטופל
- באם זוהה פרכוס - טפלו בהתאם לפרוטוקול המתאים
- בעת חשד להרעת סמים אופיאטים - תנו נרקן לפי פרוטוקול
- בדקו חום - בעת זיהוי היפותרמיה/היפרתמיה, טפלו בהתאם לפרוטוקול המתאים



1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. השכבת נשים בהיריון על צד שמאל.

2 **חמצן**
מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 92%.

3 **היפוגליקמיה**
 + כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.
 + יש לבדוק האם המטופל מחובר למשאבת אינסולין. אם כן, יש לנתק את צינורית המשאבה.
 + מתן גלוקוג'ל P.O. (15 gr) למטופל בהכרה ומשתף פעולה. למטופל בהכרה מעורפלת ניתן לתת במריחה בחלק הפנימי של הלחיים (intrabuccal).

4 **מתן גלוקוז ב-I.V.**
 + מינון – 25 gr.
 + תמיסת גלוקוז בריכוז 25%.
 + יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
 + אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

5 **נרקן**
 + מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן) ולא בהכרח לגרום להתעוררות המטופל.
 + מינון למתן ב-I.N. – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי). אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
 + מינון למתן ב-I.V. – 0.4-2 mg (מהול ב-10 ml סליין בהזרקה איטית). אם לא חל שיפור ולא הושג האפקט הרצוי, אפשר לתת מנות חוזרות כל 3-5 דקות.
 + מינון מקסימלי מצטבר 10 mg.

תוכן עניינים > כללי : פרק 3

היפוגליקמיה

+ תסמינים סובייקטיביים

- תופעות נוירוגניות – רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

+ סימנים אובייקטיביים

- חיוורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

+ סימנים

- ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב־Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). כמו כן ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

+ דגשים לבדיקה הגופנית

- בחולים אונקולוגיים יש לחפש נוכחות מדבקות לשחרור מושהה של תרופות.
- בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.

גורמים נוספים

- חבלת ראש – תשאול ו/או סימנים קליניים לחבלת ראש.
- מחלת חום זיהומית.
- גורמים סביבתיים – הרעלות (בנזודיאזפינים, זרחנים אורגנים) היפותרמיה/היפותרמיה, כגיעות בעלי חיים.
- הפרעות מטבוליות/אלקטרוליטריות (היפותרמיה, היפרקלצמיה).
- נוירולוגי – אירוע מוחי, לאחר פרכוס, גידול וכדומה.